

Co się dzieje *w mózgu* w BDD

Jamie Feusner i współpracownicy z UCLA pokazali w badaniach neuroobrazowych: mózg osoby z BDD przetwarza obraz ciała inaczej. To nie wyobraźnia — to mierzalna różnica w pracy konkretnych obszarów.

CZAS: 15 min — przeczytanie **Wiedza o mechanizmie** **ŹRÓDŁO:** Feusner i wsp. (2007, 2010, 2011)

JAK UŻYWAĆ

Feusner i wsp. (UCLA) w serii badań fMRI (od 2007) wykazali, że w BDD **system wzrokowy** przetwarza obraz ciała inaczej niż u osób zdrowych. Trzy kluczowe odkrycia: **1)** osoby z BDD patrząc na twarz (własną lub cudzą) aktywują **nadmiernie** lewą półkulę i obszary „analizy detalu” (przetwarzanie detali wysokiej częstotliwości — czyli małych cech), zamiast prawej półkuli i obszarów „analizy całości” (niskiej częstotliwości — całościowych wzorców), **2)** nadaktywność kory orbitofrontalnej i zakrętu obręczy (związane z reakcjami emocjonalnymi i kompulsjami — wspólne z OCD), **3)** zaburzenia połączeń między obszarami przetwarzania wizualnego a emocjonalnymi — **obraz wzrokowy** jest „znakowany” silnymi emocjami negatywnymi automatycznie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Te badania mają trzy praktyczne konsekwencje. **Po pierwsze**, BDD *nie jest* „wyobraźnią” ani „złym nastawieniem” — jest mierzalnym zaburzeniem przetwarzania wzrokowego. Osoba z BDD **naprawdę widzi** defekt, którego nie ma — bo jej mózg pracuje na detalach kosztem całości. **Po drugie**, leczenie nie polega na „przekonaniu się, że nie ma defektu”. Polega na **retrenowaniu** przetwarzania wzrokowego: ćwiczenia mirror retraining i trening uwagi **fizycznie zmieniają** wzorce aktywacji mózgu (Feusner 2011 — badania kontrolne po CBT pokazują normalizację). **Po trzecie**, leki SSRI w wyższych dawkach **modulują** przetwarzanie emocjonalne — stąd ich skuteczność. To *nie jedyne* narzędzie, ale ważne dla pacjentów z ciężkimi objawami. Wiedza o neurobiologii daje **język dla rozumienia siebie**: nie „jestem niewdzięcznikiem”, lecz „mój system wzrokowy pracuje inaczej”.

01 = Trzy kluczowe odkrycia Feusnera

1 · DETAL KOSZTEM CAŁOŚCI (FEUSNER 2007)

Osoby z BDD patrząc na własną twarz aktywują nadmiernie obszary *analizy lokalnej* (wysoka częstotliwość — drobne cechy) zamiast *analizy globalnej* (niska częstotliwość — całościowy wzorec). Mózg patrzy „pod lupą”, nie „z odległości”. To wzorec mierzalny w eye-trackerze: oczy fiksują się na małych obszarach 3–5x dłużej niż u osób zdrowych.

2 · NADAKTYWNOŚĆ SYSTEMU EMOCJONALNEGO (FEUSNER 2010)

Kora orbitofrontalna i zakręt obręczy — obszary kojarzone z reakcjami emocjonalnymi i kompulsjami (te same, które są nadaktywne w OCD). W BDD aktywują się *silnie*, gdy osoba patrzy na własną twarz. Stąd intensywne emocje przy każdym spojrzeniu w lustro.

3 · ZABURZENIA ŁĄCZNOŚCI (FEUSNER 2011)

Połączenia między obszarami wzrokowymi a emocjonalnymi są **zwiększone**. Obraz wzrokowy własnej twarzy automatycznie wyzwała intensywną reakcję emocjonalną. „Widzę twarz — czuję wstyd” jest *jednostką*, nie sekwencją myśli.

TO NIE WINA CHARAKTERU

Twój mózg przetwarza obraz ciała inaczej — to *fizjologia*, nie wybór. Nie jesteś „narcystyczny/-a” ani „przewrażliwiony/-a”. Masz zaburzenie z mierzalnym podłożem.

NAPRAWDĘ WIDZISZ INACZEJ

„Wszyscy patrzą i widzą” — w Twoim doświadczeniu prawdziwe. Ale inni nie aktywują tego samego wzorca przetwarzania. Oni widzą całość, Ty widzisz detal.

OPERACJA NIE ZMIENI MÓZGU

Zabieg zmienia *fizjologię* twarzy. Nie zmienia *sieci neuronalnej* przetwarzającej obraz. Mózg dalej będzie patrzeć detalicznie. Dlatego operacja w BDD nie pomaga (osobny handout).

CBT ZMIENIA MÓZG

Feusner (2011) pokazał: po 12 tygodniach CBT-BDD wzorce *aktywacji* w mózgu zaczynają normalizować się. Mózg uczy się patrzeć inaczej — fizjologicznie.

● Trzy ścieżki leczenia, które mają korelat neurobiologiczny

1. CBT-BDD (mirror retraining, trening uwagi): bezpośrednio adresuje wzorzec „*patrzenia detalicznego*”. Po terapii eye-tracker pokazuje *poszerzony* pattern fiksacji wzroku. Wzorzec się *fizycznie* zmienia.

2. SSRI w wyższych dawkach (fluoksetyna 40-80 mg, escitalopram 20-30 mg): moduluje przetwarzanie emocjonalne, obniża nadaktywność systemu emocjonalnego. Działa u 60% pacjentów. Wymaga 12 tygodni próby — krótkie kuracje nie wystarczają.

3. Połączenie CBT + SSRI: najlepsze wyniki u pacjentów z umiarkowanym/ciężkim BDD. CBT zmienia uwagę, SSRI obniża intensywność reakcji emocjonalnych. Równolegle.

Klucz: Feusner (2010): „*BDD nie jest problemem charakteru ani wyglądu. Jest zaburzeniem przetwarzania obrazu ciała w mózgu. Świadomość mechanizmu nie redukuje cierpienia od razu — ale daje pacjentowi konkretny język do rozumienia siebie i nadziei na zmianę*”. Twój mózg może się nauczyć patrzeć inaczej. Wymaga to terapii, czasem leków, czasu i cierpliwości. Ale jest możliwe — bo to fizjologia, którą można modulować.